MAPFRE

INFORME DE RECHAZO N°00027-2026-AVF

Paciente	**:** Victor Hugo Zavaleta Garcia
Edad	**:** 42 años
Empresa	**:** EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.
Ocupación	**:** Electricista Mantenimiento II
Fecha de accidente	**:** 02/09/2026
Fecha de informe	**:** 09/10/2026

I. Introducción

Se realiza la evaluación del expediente médico del paciente **VICTOR HUGO ZAVALETA GARCIA**, quien presenta los siguientes diagnósticos propuestos:

1. **Esguince y torceduras de otras partes y las no especificadas de la rodilla (CIE-10: S83.6)**
2. **Dolor en articulación (CIE-10: M25.5)**
3. **Desgarro horizontal del menisco externo**
4. **Fracturas / rupturas radiales múltiples del cuerno anterior del menisco interno**
5. **Esguince / alteración fibrilar del ligamento cruzado anterior (LCA)**
6. **Tendinosis del cuádriceps y Bursitis suprapatelar**

II. Revisión del Caso

• **Antecedentes del accidente:** Según la Solicitud de Atención Médica por Accidente de Trabajo (Formato N° 1), el evento ocurrió el **02/09/2026 a las 22:10 h** en la Mesa de Colada. El colaborador refiere que mientras se encontraba en posición de cuclillas desconectando un sensor de nivel, al **incorporarse (ponerse de pie)** presentó un "tirón" en la región poplítea izquierda, seguido de dolor al pisar e irradiado a la rodilla izquierda.

• **Historia clínica:** Acude a primera atención el 08/09/2026 refiriendo dolor e impotencia funcional en rodilla izquierda que dificulta los movimientos de flexión, extensión y subir escaleras.

• **Estudios complementarios:**

- **Resonancia Magnética de Rodilla Izquierda (10/09/2026):** Evidencia tendinosis del cuádriceps, esguince/engrosamiento del LCA (9.4 mm) con alteración de patrón fibrilar, bursitis suprapatelar, fracturas/rupturas radiales múltiples en el cuerno anterior del menisco interno y desgarro horizontal del menisco externo.

III. Análisis Médico

Tras la revisión de la documentación clínica y la literatura médica ortopédica, se realiza la evaluación del nexo de causalidad biomecánico y epidemiológico utilizando los **Criterios de Bradford Hill**:

1. **Fuerza de Asociación y Plausibilidad Biomecánica:**

El acto fisiológico de ponerse de pie desde la posición de cuclillas implica un vector de fuerza axial sin rotación ni impacto traumático de alta energía. Desde el punto de vista ortopédico, este mecanismo es **insuficiente** para producir simultáneamente una rotura multiligamentaria y meniscal severa (compromiso de ambos meniscos y ligamento cruzado anterior) en una estructura articular sana.

2. **Temporalidad:** Aunque los síntomas se manifestaron al incorporarse, la morfología de los hallazgos en la Resonancia Magnética (desgarro horizontal meniscal y tendinosis cuadricipital) representa alteraciones estructurales crónicas y remodelaciones tisulares que tardan meses en desarrollarse, descartando un origen agudo exclusivo del evento reportado.
3. **Coherencia y Analogía Clínica:** Los desgarros con patrón horizontal y las tendinosis patelares/cuadricipitales están ampliamente catalogados en la literatura como **patologías degenerativas y de desgaste microtraumático acumulativo**, no como lesiones traumáticas agudas aisladas por esfuerzo biomecánico simple.
4. **Especificidad:**

   El cuadro clínico presentado corresponde a la **sintomatización o descompensación de una patología osteomuscular preexistente y/o degenerativa**, donde el esfuerzo de ponerse de pie actuó únicamente como gatillante del dolor, más no como la causa eficiente del daño estructural masivo.

Por lo tanto, los hallazgos intraarticulares complejos (desgarros meniscales crónicos, tendinosis y esguince ligamentario por alteración previa) **no guardan relación causal directa con el accidente laboral descrito**, no cumpliendo con los criterios de cobertura del SCTR.

V. Conclusión

Con base en la historia clínica, los estudios de imágenes de Resonancia Magnética, el análisis biomecánico de causalidad y la normativa vigente de accidentes de trabajo, se determina que los diagnósticos de **desgarro meniscal medial y lateral, tendinosis cuadricipital y alteración ligamentaria estructural** no se encuentran vinculados al accidente de trabajo reportado.

VI. Decisión

Se rechaza la cobertura bajo la póliza SCTR para las prestaciones asistenciales o intervenciones derivadas de los diagnósticos estructurales degenerativos/crónicos de la rodilla izquierda (desgarros meniscales complejas y tendinosis), al tratarse de patologías preexistentes descompensadas y sin nexo causal directo con el mecanismo traumático relatado.

Atentamente,

Gestor SCTR MAPFRE
Auditoría Médica /Ocupacional